BONUS 3

Popis podle klinické otázky: 30 klinických otázek

Ať už je otázka na žádance jakákoli, první věta vašeho popisu by na ni měla odpovědět. U 30 nejčastějších klinických otázek: co musí popis bezpodmínečně zodpovědět, negativní formulace a pozitivní formulace.

Obsah

Proč je klinická otázka na prvním místě

Neuroradiologie — 5 otázek

Hrudník — 7 otázek

Břicho a pánev — 10 otázek

Vaskulární — 3 otázky

Muskuloskeletální a páteř — 5 otázek

Další krok

ÚVODEM

Proč je klinická otázka na prvním místě

V kroku PŘIPRAVTE čtete žádanku; v kroku SHRŇTE na ni odpovídáte.

> *Když indikující lékař otevře popis, hledá jedinou věc: odpověď na svou otázku. Pokud ji nenajde, zavolá, nebo si popis špatně vyloží.*

1. **Přečtěte si žádanku a zredukujte otázku na jediné slovo** — «apendicitida?», «krvácení?», «litiáza?».
2. **Prohlídku proveďte opět kompletně** — otázka určuje zaměření, ale ostatní oblasti se neopomíjejí.
3. **Seznam položek, které otázka „nutně vyžaduje“, pokryjte v Nálezu** — každá položka se píše buď jako pozitivní, nebo jako významný negativní nález.
4. **První věta Závěru odpovídá na položenou otázku** — při pozitivitě nález a v případě potřeby hlášení; při negativitě jednoznačná negativní formulace.
5. **Uveďte limitace vyšetření** — pokud vyšetření nepostačuje k vyloučení otázky, výslovně to uveďte.

Pokud je žádanka nejasná

U nejasných žádanek jako «kontrola» nebo «bolest» se pokuste zjistit klinické informace ze záznamu nebo od indikujícího lékaře. Pokud je nezjistíte, strukturujte popis podle nejpravděpodobnější otázky a odpovězte postupně na časté příčiny.

KAPITOLA 1

Neuroradiologie

5 klinických otázek

01 «CMP?»

Často používané vyšetření: Nekontrastní CT mozku ± CT angiografie; DWI MR

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Zda je krvácení přítomno či nikoli (první věta)
- Časné známky ischemie a vaskulární teritorium
- Příznak hyperdenzní arterie
- Pokud byla provedena CT angiografie, uzávěr velkých cév
- Čas nahlášení

NEGATIVNÍ VĚTA

Intrakraniální krvácení neprokázáno. Časné ischemické změny nezastiženy; časná ischemická CMP nemusí být na nekontrastním CT patrná.

POZITIVNÍ VĚTA

Bez intrakraniálního krvácení; [vpravo/vlevo] Známky časné akutní ischemie v povodí ACM. V rámci iktového protokolu [hodin] bylo hlášeno v.

02 «Kraniotrauma – krvácení?»

Často používané vyšetření: Nekontrastní CT mozku (mozkové a kostní okno)

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Extraaxiální a parenchymové krvácení
- Expanzivní chování a přetlačení středočárových struktur (mm)
- Bazální cisterny
- Fraktura kalvy a baze lební
- Pneumocefalus

NEGATIVNÍ VĚTA

Bez známek akutního intrakraniálního krvácení, expanzivního chování či fraktury kalvy.

POZITIVNÍ VĚTA

[Vpravo/Vlevo] akutní [epidurální/subdurální] hematom; [.. mm] přetlačení středočárových struktur. [Hodina] bylo hlášeno v.

03 «Náhlá prudká bolest hlavy – SAK?»

Často používané vyšetření: Nekontrastní CT mozku ± CT angiografie

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Subarachnoidální krvácení a jeho distribuce
- Hydrocefalus
- Intraventrikulární nebo parenchymové krvácení
- Doporučení CTA pro posouzení aneuryzmatu

NEGATIVNÍ VĚTA

Subarachnoidální krvácení nezjištěno. Senzitivita CT klesá s časem od vzniku obtíží; při přetrvávajícím klinickém podezření je další postup ponechán na klinickém zvážení.

POZITIVNÍ VĚTA

[V bazálních cisternách] subarachnoidální krvácení; hydrocefalus [není/je přítomen]. Doporučuje se CT angiografie. [Hodina] bylo hlášeno v.

04 «Expanze?»

Často používané vyšetření: MR mozku s kontrastem (při pochybnostech na CT)

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Počet, lokalizace a velikost lézí
- Diferenciace intra/extraaxiální
- Edém a expanzivní chování
- Herniace
- Nejpravděpodobnější diferenciální diagnóza

NEGATIVNÍ VĚTA

Na MR mozku s kontrastem nezjištěna expanzivní léze ani patologické sycení.

POZITIVNÍ VĚTA

[Vpravo/Vlevo] [lalok] v [.. mm] [intraaxiální/extraaxiální] expanze/léze; [diferenciální diagnóza]. Známky herniace [není/je přítomen].

05 «Hydrocefalus / dysfunkce zkratu?»

Často používané vyšetření: Nekontrastní CT mozku; porovnání s předchozím vyšetřením

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Změna velikosti komor ve srovnání s předchozím vyšetřením
- Periventrikulární edém
- Poloha konce šantového katétru
- Krvácení

NEGATIVNÍ VĚTA

Oproti předchozímu vyšetření bez změny šíře komor; konec šantového katétru [lokalizace].

POZITIVNÍ VĚTA

Oproti předchozímu vyšetření výrazná progrese šíře komor; může svědčit pro dysfunkci šantu. [Hodina] bylo hlášeno v.

KAPITOLA 2

Hrudník

7 klinických otázek

06 «Pneumotorax?»

Často používané vyšetření: RTG hrudníku; v případě potřeby CT nebo POCUS

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Zda je přítomen pneumotorax, strana
- Rozměr nebo množství
- Známky svědčící pro tenzi
- Přidružená fraktura žeber, podkožní emfyzém

NEGATIVNÍ VĚTA

Pneumotorax nezjištěn.

POZITIVNÍ VĚTA

[Vpravo/Vlevo] pneumotorax, apikálně [.. mm]; známky tenze [není/je přítomen]. [Hodina] bylo hlášeno v.

07 «Pneumonie?»

Často používané vyšetření: RTG hrudníku; v případě potřeby CT hrudníku

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Zda je přítomna konsolidace, lalok/segment
- Pleurální výpotek
- Kavitace nebo absces
- Změna oproti předchozímu vyšetření

NEGATIVNÍ VĚTA

V plicním parenchymu bez konsolidací svědčících pro pneumonii.

POZITIVNÍ VĚTA

[Vpravo/Vlevo] [lalok] konsolidace; v korelaci s klinickým stavem může odpovídat pneumonii. Pleurální výpotek [není/je přítomen].

08 «Plicní embolie?»

Často používané vyšetření: CT plicní angiografie

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Adekvátnost opacifikace
- Je přítomna embolie a nejproximálnější úroveň
- Přetížení pravé komory
- Alternativní diagnóza (pneumonie, efuze)

NEGATIVNÍ VĚTA

Opacifikace plicnice je adekvátní; plicní embolie nezjištěna.

POZITIVNÍ VĚTA

[Bilaterálně] **[lobární/segmentální]** akutní plicní embolie; přetížení pravé komory **[není/je přítomen]**. **[Hodina]** bylo hlášeno v.

09 «Disekce aorty?»

Často používané vyšetření: CT angiografie (nativní + arteriální fáze)

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Je přítomna disekce
- Postižení vzestupné aorty
- Postižení větví a perfuze orgánů
- Perikardiální výpotek, mediastinální hematom
- Intramurální hematom

NEGATIVNÍ VĚTA

Aortální disekce, intramurální hematom ani penetrující vřed nebyly zjištěny.

POZITIVNÍ VĚTA

[Stanford A/B] disekce aorty; **[postižení větví]**. Urgentní nález; **[hodin]** bylo hlášeno v.

10 «Poloha tubusu / katétru?»

Často používané vyšetření: Lůžkový AP skiagram hrudníku

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Kde se nachází hrot každého prostředku
- Vzdálenost ETT od kariny
- Zda je NG sonda v žaludku
- Pneumotorax v souvislosti s intervencí

NEGATIVNÍ VĚTA

Hrot ETT od kariny **[.. cm]** nad, konec NGS v projekci žaludku, konec CŽK v projekci horní duté žíly; bez pneumotoraxu.

POZITIVNÍ VĚTA

[Konec NG sondy v projekci pravého hlavního bronchu], není ve správné poloze. Před použitím **[hodin]** bylo hlášeno v.

11 «Srdeční selhání / plicní edém?»

Často používané vyšetření: RTG hrudníku; UZ plic

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Velikost srdce (s uvedením projekce)
- Cévní kongesce a intersticiální edém
- Pleurální výpotek
- Změna oproti předchozímu vyšetření

NEGATIVNÍ VĚTA
Nezjištěny známky svědčící pro plicní edém ani pleurální výpotek.

POZITIVNÍ VĚTA
Nález svědčící pro plicní edém a oboustranně malé množství pleurálního výpotku; oproti předchozímu vyšetření [progrese/regrese].

12 «Pleurální výpotek?»

Často používané vyšetření: RTG hrudníku; UZ hrudníku

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Je přítomen výpotek, strana
- Množství
- Obsah (UZ: anechogenní, se septy, echogenní)
- Podkladová patologie parenchymu
- Vhodné okno pro intervenci (pokud je požadováno)

NEGATIVNÍ VĚTA
Pleurální výpotek nezjištěn.

POZITIVNÍ VĚTA
[Vpravo/Vlevo] [malé/střední/velké množství] množství [anechogenní/komplikovaného vzhledu] pleurální výpotek.

KAPITOLA 3

Břicho a pánev

10 klinických otázek

13 «Apendicitida?»

Často používané vyšetření: Dítě/mladý pacient/těhotná: UZ; dospělý: kontrastní CT

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Byl apendix zobrazen
- Průměr, stěna, okolní tuková tkáň
- Apendikolit
- Perforace, absces
- Pokud nebyl zobrazen, že to nevylučuje apendicitidu

NEGATIVNÍ VĚTA
Apendix je normálního vzhledu; známky akutní apendicitidy nebyly zjištěny.

POZITIVNÍ VĚTA
Nález svědčící pro akutní apendicitidu; perforace nebo absces [není/je přítomen]. [Hodina] bylo hlášeno v.

14 «Litiáza? (renální kolika)»

Často používané vyšetření: Nekontrastní CT (kamenový protokol); UZ

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Přítomnost konkrementu, lokalizace a velikost (mm)
- Stupeň hydronefrózy
- Kontralaterální ledvina
- Alternativní diagnóza

NEGATIVNÍ VĚTA
V močovém traktu nebyla zjištěna litiáza ani hydronefróza.

POZITIVNÍ VĚTA
[Vpravo/Vlevo] [distální] v ureteru [.. mm] konkrement a [mírný/á/é] hydroureteronefróza.

15 «Cholecystitida?»

Často používané vyšetření: UZ břicha

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Konkrement
- Tloušťka stěny a pericholecystická tekutina
- Sonografický Murphyho příznak
- Šíře choledochu
- Komplikace (gangréna, perforace)

NEGATIVNÍ VĚTA
Žlučník v normě; známky litiázy či akutní cholecystitidy nezjištěny. Choledochus [.. mm].

POZITIVNÍ VĚTA
Nález svědčící pro akutní kalkulózní cholecystitidu; choledochus [.. mm]. [Hodina] bylo hlášeno v.

16 «Obstrukce / ileus?»

Často používané vyšetření: Nativní RTG břicha vestoje; kontrastní CT břicha

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Zda je přítomna obstrukce, tenké/tlusté střevo
- Přechodová zóna a možná příčina
- Známky strangulace/ischémie
- Volný plyn

NEGATIVNÍ VĚTA
Nezjištěny známky svědčící pro mechanický ileus.

POZITIVNÍ VĚTA
[Oblast] mechanický ileus tenkého střeva s tranzitorickou zónou v; známky ischémie [není/je přítomen].

17 «Perforace / volný vzduch?»

Často používané vyšetření: RTG hrudníku vestoje; CT břicha

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Je přítomen volný plyn
- Pravděpodobné místo perforace
- Volná tekutina, absces
- Nedávný chirurgický výkon v anamnéze

NEGATIVNÍ VĚTA
Volný plyn nezjištěn.

POZITIVNÍ VĚTA
Pneumoperitoneum; [možná lokalizace] svědčí pro perforaci. [Hodina] bylo hlášeno v.

18 «Pankreatitida / komplikace?»

Často používané vyšetření: CT břicha s kontrastem (obvykle s odstupem od začátku)

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Typ pankreatitidy (edematózní/nekrotizující)
- Peripankreatická tekutina nebo kolekce
- Vaskulární komplikace
- Žlučový konkrement

NEGATIVNÍ VĚTA
Nebyly zjištěny známky svědčící pro akutní pankreatitidu.

POZITIVNÍ VĚTA
Akutní **[nekrotizující]** pankreatitida; **[kolekce/vaskulární komplikace]** **[není/je přítomen]**.

19 «Trauma — poranění parenchymatózních orgánů?»

Často používané vyšetření: Trauma CT s kontrastem; FAST

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Každý parenchymatózní orgán jednotlivě
- Hemoperitoneum a jeho množství
- Aktivní extravazace
- Poranění střeva/mezenteria
- Kostní poranění

NEGATIVNÍ VĚTA
Nezjištěny známky poranění parenchymatózních orgánů, volné tekutiny ani aktivního krvácení.

POZITIVNÍ VĚTA
[Orgán] poranění a hemoperitoneum; aktivní extravazace **[není/je přítomen]**. **[Hodina]** bylo hlášeno v.

20 «Ektopická gravidita?»

Často používané vyšetření: Transvaginální a transabdominální UZ pánve

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Přítomnost intrauterinního těhotenství
- Adnexální expanze
- Volná tekutina a její charakter
- Stav ovarií

NEGATIVNÍ VĚTA
V děložní dutině **[obsahující žloutkový váček]** zobrazen gestační váček; adnexální rezistence ani volná tekutina nezastiženy.

POZITIVNÍ VĚTA
Intrauterinní těhotenství nezastiženo; **[vpravo/vlevo]** s adnexální rezistencí a volnou tekutinou, nález svědčí pro ektopickou graviditu. **[Hodina]** bylo hlášeno v.

21 «Divertikulitida?»

Často používané vyšetření: CT břicha a pánve s kontrastem

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Postižený segment
- Zda je komplikovaná (absces, perforace, píštěl)
- Velikost abscesu
- Alternativní diagnóza

NEGATIVNÍ VĚTA
Známky divertikulitidy nebyly zjištěny.

POZITIVNÍ VĚTA
[Sigmoideum] akutní v tračníku [komplikovaná/nekomplikovaná] divertikulitida; absces [není/je přítomen, .. mm].

22 «Bolest břicha — příčina?»

Často používané vyšetření: CT břicha a pánve s kontrastem nebo UZ

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Je přítomna akutní chirurgická patologie
- Časté příčiny jednotlivě: apendix, žlučník, střevo, močový trakt
- Volná tekutina a volný plyn
- Vaskulární patologie (aorta)

NEGATIVNÍ VĚTA
Nezjištěna akutní patologie vysvětlující bolesti břicha.

POZITIVNÍ VĚTA
[Nález]; může vysvětlovat bolest břicha. [V případě potřeby hlášení].

KAPITOLA 4

Vaskulární

3 klinické otázky

23 «HŽT?»

Často používané vyšetření: Venózní Doppler UZ dolních končetin

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Které segmenty byly hodnoceny
- Kompresibilita
- Proximální hranice trombu
- Byly zhodnoceny lýtkové žíly

NEGATIVNÍ VĚTA

[Vpravo/Vlevo] v hlubokých žilách dolní končetiny [v hodnocených segmentech] trombóza nezastižena.

POZITIVNÍ VĚTA

[Vpravo/Vlevo] [femoropopliteální] akutní HŽT v segmentu; proximální hranice [úroveň]. [Hodina] bylo hlášeno v.

24 «Torze varlete?»

Často používané vyšetření: UZ skrota v šedé škále a barevném Doppleru

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Intratestikulární průtok (ve srovnání s druhou stranou)
- Velikost a echotextura varlete
- Semenný provazec
- Alternativní diagnóza (epididymitida)

NEGATIVNÍ VĚTA

Oboustranný testikulární tok je symetrický; známky torze nebyly zjištěny. Přítomnost toku zcela nevylučuje intermitentní torzi.

POZITIVNÍ VĚTA

[Vpravo/Vlevo] průtok ve varleti nezastižen; obraz odpovídá torzi. Akutní nález; [hodin] bylo hlášeno v.

25 «AAA / ruptura?»

Často používané vyšetření: UZ břišní aorty; CT angiografie

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Maximální průměr (mm)
- Vztah k renálním tepnám
- Periaortální hematom (ruptura)
- Limitace UZ u symptomatického pacienta

NEGATIVNÍ VĚTA

Břišní aorta normálního kalibru; bez průkazu aneuryzmatu.

POZITIVNÍ VĚTA

Infrarenální AAA, maximální průměr **[.. mm]**; známky ruptury **[není/je přítomen]**. **[Hodina]** bylo hlášeno v.

KAPITOLA 5

Muskuloskeletální a páteř

5 klinických otázek

26 «Fraktura?»

Často používané vyšetření: RTG snímek (nejméně dvě projekce); v případě potřeby CT/MR

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Zda je přítomna fraktura, kost a etáž
- Intraartikulární propagace
- Dislokace, angulace
- Luxace
- Pokud je RTG negativní, možnost okultní fraktury

NEGATIVNÍ VĚTA

Akutní fraktura ani luxace nezastižena. Při přetrvávajícím klinickém podezření nelze okultní frakturu prostým snímkem vyloučit.

POZITIVNÍ VĚTA

[Vpravo/Vlevo] [kost] [lokalizace] fraktura; [intraartikulární/extraartikulární], [dislokace].

27 «Zlomenina kyčle? (senior, pád)»

Často používané vyšetření: AP pánve + axiální snímek kyčle; při negativitě MR nebo CT

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Krček femuru a intertrochanterická oblast
- Dislokace
- Pánevní kruh a ramena stydkých kostí
- Doporučení doplňujícího vyšetření pro suspektní okultní zlomeninu

NEGATIVNÍ VĚTA

V oblasti kyčle a pánve nebyla zjištěna akutní fraktura. Při vysokém klinickém podezření se k vyloučení okultní zlomeniny doporučuje MR nebo CT.

POZITIVNÍ VĚTA

[Vpravo/Vlevo] fraktura krčku femuru ([dislokovaná/nedislokovaná]).

28 «Útlak míchy / cauda equina?»

Často používané vyšetření: MR celé páteře nebo bederní páteře

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Je přítomna komprese, etáž a příčina
- Změna signálu míchy
- Kořeny cauda equina
- Další etáže

NEGATIVNÍ VĚTA
Komprese míchy ani cauda equina nezjištěna.

POZITIVNÍ VĚTA
[Úroveň] v úrovni [příčina] s útlakem míchy. Akutní nález; [hodin] bylo hlášeno v.

29 «Cervikální trauma — fraktura?»

Často používané vyšetření: CT krční páteře

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Postavení
- Známky fraktury a nestability
- Kraniocervikální přechod
- Prevertebrální měkké tkáně
- Nutnost MR k posouzení ligamentózního poranění

NEGATIVNÍ VĚTA
Na krční páteři nezjištěna akutní fraktura ani porucha osového postavení.

POZITIVNÍ VĚTA
[Úroveň] v úrovni [fraktura/luxace]; z hlediska nestability [hodin] bylo hlášeno v.

30 «Septická artritida / osteomyelitida?»

Často používané vyšetření: RTG snímek; UZ (výpotek); MR

POPIS MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZODPOVĚDĚT

- Kloubní výpotek
- Postižení kostní dřeně
- Absces měkkých tkání
- Omezení zobrazovacích metod (nutnost aspirace je klinickým rozhodnutím)

NEGATIVNÍ VĚTA
[Kloub] výpotek nezastižen; změny kostní dřeně svědčící pro osteomyelitidu neprokázány.

POZITIVNÍ VĚTA
[Kloub] výpotek a [edém kostní dřeně/absces]; doporučuje se akutní klinické vyšetření k vyloučení septické artritidy/osteomyelitidy. [Hodina] bylo hlášeno v.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní si otevřete Rychlý bonus · Jednostránkový kontrolní seznam popisu. Odpověď na klinickou otázku, strana, rozměr, porovnání a hlášení: zkontrolujte během jedné minuty před podpisem.

Pro kompletní šablony popisů **Hlavní materiál · 120 šablon hotových popisů**se můžete vrátit.